

眼科诊断报告

诊断报告 ID: 13

关联记录 ID: 25

生成时间: 2025-03-13T13:19:58

报告格式: PDF

语言版本: ZH

报告内容：

=== 眼科诊断报告 ===

患者信息：

姓名：杨** | 性别：男 | 年龄：2 | 身份证：***115180

诊断结论：

左眼：AMD(AMD) 置信度：0.43

近视相关病变(MYO) 置信度：99.38

其他异常(OTHER) 置信度：0.11

右眼：正常(NORMAL) 置信度：82.29

青光眼(GLAU) 置信度：10.97

其他异常(OTHER) 置信度：3.15

左眼病变分析：

--描述：黄斑区视网膜色素上皮-Bruch膜-脉络膜复合体退行性改变

--病变分析：

1.干性型：玻璃膜疣沉积 $>63\mu\text{m}$ ，RPE地图状萎缩

2.湿性型：脉络膜新生血管（CNV）形成

3.OCT显示视网膜下高反射物质

4.FFA可见窗样缺损或荧光渗漏

--描述：眼轴 $>26\text{mm}$ 的高度近视继发退行性改变

--病变分析：

1.后巩膜葡萄肿（黄斑区脉络膜萎缩）

2.Fuchs斑（RPE增殖性改变）

3.漆裂纹（Bruch膜断裂）

4.周边视网膜格子样变性

5.并发性白内障（核性混浊为主）

--描述：需结合影像学特征及实验室检查进一步明确

右眼病变分析：

--描述：视网膜各象限结构完整，血管走行正常，无视网膜脱离、出血、渗出等病理改变，黄斑中心凹反光存在

--描述：病理性眼压升高导致特征性视神经萎缩和视野缺损的不可逆性致盲眼病

--病变分析：

1.视杯垂直径扩大（ $C/D > 0.6$ ）

2.视网膜神经纤维层楔形缺损

3.视野鼻侧阶梯、旁中心暗点

4.房角镜检查显示开角/闭角结构异常

5.24小时眼压波动 $> 8\text{mmHg}$

--描述：需结合影像学特征及实验室检查进一步明确

左眼治疗建议：

--分型治疗方案：

--干性AMD

1.AREDS2配方补充（维生素C+E+锌+叶黄素）

2.严格戒烟+Omega-3脂肪酸摄入

--湿性AMD

1.抗VEGF治疗标准方案： · 负荷期：雷珠单抗0.5mg 每月1次×3月 · 维持期：PRN或Treat-and-Extend策略

2.难治病例：PDT联合治疗

--综合防控体系：

--屈光矫正

1.角膜塑形镜（OK镜）控制进展（年增长 $\leq 0.25D$ ）

2.后巩膜加固术（眼轴 $> 28mm$ ）

--并发症处理

1.视网膜裂孔：532nm激光光凝

2.黄斑出血：口服止血祛瘀中药（和血明目片）

3.脉络膜新生血管：抗VEGF玻璃体注射

--精准诊疗路径：

1.感染性病变：病原学检查（PCR/涂片）指导抗微生物治疗

2.肿瘤性病变：广角眼底照相+UBM检查定位后转诊眼科肿瘤专科

3.遗传性疾病：基因检测（如RP患者行全外显子测序）

右眼治疗建议：

--健康管理建议：

--随访计划：

1. ≥ 40 岁：每年眼科综合检查（IOP+OCT+眼底彩照）

2.高度近视者：每6个月广角眼底筛查

--健康教育：

1.20-20-20法则预防视疲劳

2.紫外线防护（UV400镜片）

--分级干预方案：

--开角型青光眼

1.一线用药：前列腺素类似物（拉坦前列素每晚1次）

2.二线方案： β 受体阻滞剂（噻吗洛尔）+ α_2 激动剂（溴莫尼定）

3.激光治疗：选择性激光小梁成形术（SLT）

--闭角型青光眼急性发作

1.紧急降眼压：
· 全身应用高渗剂（20%甘露醇静滴）

· 局部缩瞳剂（2%毛果芸香碱q15min×2h）

2.缓解期：YAG激光周边虹膜切开术（LPI）

--终末期管理

1.滤过手术：小梁切除术联合丝裂霉素C应用

2.植入物引流：Ahmed青光眼阀植入

--精准诊疗路径：

1.感染性病变：病原学检查（PCR/涂片）指导抗微生物治疗

2.肿瘤性病变：广角眼底照相+UBM检查定位后转诊眼科肿瘤专科

3.遗传性疾病：基因检测（如RP患者行全外显子测序）

左眼检测如下：

右眼检测如下：

